

Résumé — Malvoyance chez l'Enfant

Dr Hassairi Asma | Orthoptie – Cours n°1

1. Définitions (selon l'OMS)

L'OMS classe les déficiences visuelles selon deux critères de performance visuelle :

Critère	Description	Seuil pathologique
Acuité visuelle (AV)	Capacité à voir distinctement les détails à une distance donnée	AV < 3/10 avec correction optique
Champ visuel	Étendue de la vision autour de l'objet fixé (normalement 180° × 130°)	Réduction significative du champ

- **Malvoyance** : déficience visuelle avec vision fonctionnelle *réadaptable*.
- À déficiences identiques, deux personnes peuvent avoir des comportements très différents selon leur utilisation de la vision fonctionnelle.
- Une **réadaptation** est nécessaire pour optimiser la vision résiduelle et les sens compensatoires.

2. Causes de malvoyance chez l'enfant

2.x Glaucome congénital

- **1ère cause de cécité infantile en Tunisie.**
- Anomalie de développement de l'angle irido-cornéen → empêche l'évacuation de l'humeur aqueuse.
- Souvent bilatéral, présent à la naissance ; héréditaire dans 50 % des cas.
- **Signes cliniques** : larmoiement clair, photophobie, cornée trouble, mégalocornée (« enfants aux trop beaux yeux »), antécédents familiaux.
- **Diagnostic** : examen sous anesthésie générale (AG) avec mesure du tonus oculaire.
- **Évolution sans traitement** : cécité par atrophie optique, buphtalmie (augmentation du volume du globe).

2.x Cataracte congénitale

- **2ème cause de cécité chez l'enfant tunisien.**
- Opacités cristalliniennes constatées à la naissance ou apparaissant plus tard.
- Trouble visuel constant.
- **Leucocorie** (pupille blanche) = signe de découverte le plus fréquent.

2.x Rétinoblastome

- Tumeur maligne primitive de la rétine, la plus fréquente chez le nourrisson et le jeune enfant.
- Signe d'appel principal : **leucocorie** (pupille jaune).
- Diagnostic précoce indispensable pour améliorer le pronostic vital et fonctionnel.

2.x Rétinopathie pigmentaire

- Ensemble de dystrophies rétinienne héréditaires.
- Atteinte du couple photorécepteur-épithélium pigmentaire (EP).
- Destruction progressive des photorécepteurs → remaniements de l'EP → amas pigmentés rétiens.

2.x Syndrome d'Usher

- Affection génétique rare (~1/25 000 naissances).
- Association : perte d'audition + perte de vision progressive.

2.x Maladie de Stargardt (dystrophie maculaire juvénile)

- Dystrophie maculaire juvénile la plus fréquente (prévalence : 1/10 000).
- Accumulation anormale de lipofuscine dans les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien.
- Transmission autosomique récessive.

2.x Malformations congénitales

- Anomalies structurelles oculaires présentes dès la naissance (colobome, microphthalmie, anophthalmie...).

2.x Forte myopie

- Myopie dégénérative avec altérations du segment postérieur pouvant engendrer une malvoyance sévère.

2.x Amblyopie

- Trouble du développement du système visuel (rétine + cortex strié et extrastrié).
- AV d'un œil ou des deux anormalement basse, ainsi que de nombreuses autres anomalies de la fonction visuelle.

2.x Rétinopathie du prématuré (RDP)

- Trouble prolifératif touchant les vaisseaux rétiens en développement chez le prématuré.
- La vascularisation rétinienne débute vers la 16e semaine et se complète vers la 40e semaine.
- Peut entraîner une mauvaise AV ou la cécité.

2.x Dystrophies cornéennes

- Altérations cornéennes primaires, bilatérales et génétiques.
- Toutes autosomiques dominantes (AD) sauf la forme maculaire (récessive).
- Apparaissent dans les premières décennies, stables ou lentement progressives.

2.x Albinisme

- Maladie génétique incurable liée à une anomalie héréditaire de la mélanine.
- Absence partielle ou totale de mélanine → dépigmentation des cheveux, ongles, yeux, peau.
- AV de mauvaise qualité ; fragilité cutanée à l'exposition solaire (risque de cancer).

2.x Malvoyance d'origine centrale (CVI)

- Troubles visuels chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, extrêmement variés.
- **Première cause de malvoyance** dans les pays développés grâce aux progrès de la réanimation néonatale (a remplacé la cataracte congénitale et la RDP).

Tableau : Types de dystrophies cornéennes

Catégorie	Exemples
Épithéliales	Dystrophie de la membrane basale, Meesmann, Reis-Bückler
Stromales	Granulaire, Lattice, Maculaire
Endothéliales	Dystrophie de Fuchs

3. Prise en charge

3.1 Volet médical

- Dépistage précoce par le pédiatre ou la puéricultrice (dès la maternité).
- Les parents sont souvent à l'origine de la première consultation ophtalmologique.
- **Règle clé** : plus le diagnostic est précoce, meilleure est la prise en charge.
- Bilan ophtalmologique + examens complémentaires : échographie, électrophysiologie visuelle, examen sous AG.

3.2 Prise en charge multidisciplinaire

L'équipe comprend :

Professionnels impliqués
Ophtalmologiste, Puéricultrice, Pédiatre, Psychiatre, Psychologue, Assistante sociale
Orthoptiste (rôle central)
Instructeur en locomotion, Psychomotricien, Ergothérapeute, Orthophoniste
Éducateur spécialisé, Pédagogue itinérant spécialisé en déficience visuelle

4. Questions fondamentales à se poser

1. L'atteinte oculaire est-elle isolée ou associée ?
2. L'atteinte est-elle stable ou en évolution ?
3. L'enfant est-il malvoyant ?
4. Une correction optique est-elle nécessaire ?
5. Existe-t-il un retard (psychomoteur, intellectuel...) pouvant retentir sur les acquisitions scolaires, lié à la déficience visuelle ?

5. Bilan oculomoteur

- Éliminer un faux strabisme (épicanthus).
- Différencier strabisme manifeste (tropie) et latent (phorie).
- Évaluer : direction, caractère constant / intermittent / alternant / monoculaire, angle de déviation.

Test d'Hirschberg (reflets cornéens) : source lumineuse centrée devant le visage → reflets doivent être centrés ; en cas de strabisme, un reflet est décentré.

Poursuite oculaire

Type de poursuite	Cotation possible
Fixation	Absente / Sporadique / Instable / Stable
Poursuite continue	Absente / Discontinue / Normale
Poursuite saccadée	Anormale / Normale

6. Bilan sensoriel

Outil	Description
Regard préférentiel	Mesure du pouvoir séparateur (tests de fréquences spatiales)
PEV (Potentiels Évoqués Visuels)	Méthode objective d'évaluation de l'AV
Réfractométrie / Skiascopie	Étude de la réfraction sous cycloplégie obligatoire
Optotypes	Mesure de l'AV morphoscopique (possible dès 2,5–3 ans)
Champ visuel	Évaluation du champ nasal et temporal (difficile chez l'enfant)
Stéréoscopie	Tests Wirt/Titmus (qualitatifs), TNO (quantitatif)

Signes de perception visuelle — Directs : localisation d'objets, mouvement de la tête/membres vers la cible, poursuite. **Indirects** : réactions posturales, variations respiratoires, sourire, expression du visage.

7. Examens complémentaires électrophysiologiques

Examen	Principe / Utilité
Potentiels Évoqués Visuels (PEV)	Mesure amplitude/latence d'une réponse électrique à une stimulation visuelle
Électrorétinogramme (ERG)	Évaluation de la fonction rétinienne globale
Électro-oculographie	Réalisée plus rarement

8. Aides visuelles

Aide	Indication
Loupes grossissantes (posées / à main, éclairantes)	Perte légère de vision de près
Verres filtrants spécifiques	Diminution de l'éblouissement, maintien de l'AV centrale
Télé-loupes montées sur lunettes (Galilée ou Kepler)	Vision de loin et de près nécessitant un grossissement important
Agrandisseurs électroniques (caméra + écran, jusqu'à ×50)	Lecture, écriture, connexion à un ordinateur